

Il vostro figlio adulto autistico che ora è genitore

Per genitori, suoceri e famiglia allargata — sostenere un adulto autistico che è (o sta per diventare) genitore.

L'idea chiave

L'autismo, attraverso il **monotropismo**, significa che l'attenzione del vostro figlio adulto si blocca in pochi „tunnel” profondi e intensi. Il genitorialità è implacabile, ad alto canale e imprevedibile — esattamente le condizioni che un sistema monotropico trova più difficili — per cui porta un **alto rischio di burnout** e spesso ignora i propri bisogni. Ma molti genitori autistici sono **assistenti eccellenti e profondamente attenti** nei loro interessi e ritmi, e la valutazione del loro bambino è spesso ciò che finalmente porta alla luce *i loro* tratti. La vostra parte: credetegli, sostenete il loro modo di fare e offrite aiuto concreto senza prendere il controllo.

Cosa potreste vedere — e cosa sta davvero accadendo

Potreste vedere...	Cosa spesso sta accadendo
Devoto/a, eppure sovraccarico/a sensorialmente e „non ce la fa”	Carico genitoriale su un sistema monotropico — alto rischio di burnout, non cattiva genitorialità
Salta i pasti, ignora il proprio dolore o esaurimento	Differenze di interocezione + iper-focus sul bambino
Routine rigide attorno al neonato	La prevedibilità riduce il carico — non „controllo”
Diagnosticato/a solo dopo il proprio bambino	Una via comune all'identificazione adulta
Vuole che aiutiate <i>a modo suo</i> , non al vostro	Una routine prevedibile e concordata abbassa il carico di tutti

Provate questo

- **Seguite la loro guida** su routine, alimentazione e addormentamento — la coerenza tra le famiglie abbassa il carico del bambino e il loro.
- **Offrite aiuto concreto** — un pasto, guardare il neonato per un'ora così che possa dormire o stare in un interesse, una corsa al supermercato. Le offerte specifiche battono „fammi sapere”.
- **Mantenetevi prevedibili** — avvisate prima delle visite; rispettate i loro bisogni sensoriali (chiamate prima, niente visite a sorpresa).
- **Protegete i loro interessi e il loro riposo** come risorse di benessere; un genitore autistico che si riposa è un genitore migliore.
- **Credetegli** se vi dicono che sono autistici o in burnout — e chiedete cosa aiuterebbe anziché consigliare.

Evitate questo

- Interpretare il sovraccarico sensoriale o lo shutdown come „non si lega” al neonato.
- Intervenire per genitore *per* loro, o disfare le loro routine „a modo vostro”.
- Aggiungere richieste imprevedibili, visite a sorpresa, o criticare un adeguamento „strano”.

Quando serve altro supporto

Guardatevi dal **burnout autistico** e dalla malattia mentale perinatale (le due si sovrappongono e entrambe richiedono cure specifiche). Segnalate il **supporto tra pari di genitori autistici** e l'aiuto pratico. Se un nipote è in valutazione, riconoscete il carico cumulativo sul genitore e incoraggiatelo a cercare supporto anche per i propri bisogni.

Se il vostro figlio è una madre

Le madri autistiche sono spesso mal-diagnosticate (ansia/depressione perinatale) e mascherano intensamente, anche con la famiglia. Chiedete di differenze sociali/sensoriali di tutta la vita, non solo dell'umore attuale, e prendete sul serio un'esteriorità „funzionante bene”.

Informazioni su questa guida

Con assistenza IA, derivata dalle bozze di ricerca del progetto — la guida per la **famiglia** (Parti 4 e 7) e la sintesi sul **Monotropismo**, con la guida **Lifespan per professionisti e sanitari** (Parte 3.4). Usa il linguaggio con l'identità per prima. **Informativa — non è consiglio medico né strumento diagnostico**. Adattatela al/dalla singolo/a.

Fonti chiave. Murray, Lesser & Lawson (2005); Murray, F. (2023); Dwyer (2025); Raymaker et al. (2020); Pearson & Rose (2021); Kelly Mahler (2024). Le citazioni complete sono nelle bozze di fonte.